SENTENÇA

Processo: 0828478-12.2023.8.19.0054

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: LEONARDO MICHALICK THOMASI

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL

I. RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por **LEONARDO MICHALICK THOMASI** em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.** Alegou que é beneficiário do plano de saúde, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, sob a matrícula 087506423. Afirmou que, conforme o laudo médico, é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID - E10) de difícil controle e que médico especialista atestou a necessidade de tratamento com Bomba Infusora de Insulina com sensor e sistema Minimed 780G, sob risco de vida, uma vez que os tratamentos anteriores não apresentam mais eficácia. Informou que contatou a ré para solicitar o tratamento, mas a operadora negou a cobertura, justificando que o procedimento é considerado um medicamento de uso domiciliar. **Pede a parte autora** i) concessão de tutela de urgência, consistente em condenar a ré ao pagamento de todos os custos relativos ao tratamento de diabetes do autor, qual seja, Bomba de Infusão de Insulina, insulinas, além dos insumos e materiais que sejam necessários ao sucesso do tratamento, mensalmente e até ulterior decisão médica; ii) indenização a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00; iii) inversão do ônus da prova.

Em decisão foi **deferida a tutela de urgência, sendo determinado que o réu forneça à parte autora, com periodicidade mensal, pelo tempo que necessário for (na vigência do contrato), os aparelhos de insumos descritos** pelo médico assistente, constantes no id. 94070982 [id 96029202].

Citado, o réu, apresentou contestação e pugnou pela revogação da tutela e improcedência dos pedidos. Alegou que o autor não busca o custeio de tratamento, mas sim quer obrigar a ré arcar com os custos de materiais que não possuem ligação com ato cirúrgico. Afirmou que a ANS, por força da Lei 9.656/98, atestou que os operadores de saúde não são obrigados ao custeio de materiais não ligados a atos cirúrgicos. O pedido de "bomba de insulina" não tem cobertura obrigatória. Por fim, afirmou que o autor não comprovou a ausência de sucesso com tratamentos diversos [id 103828781].

Acórdão proferido em id 118922861 deu provimento ao recurso e determinou que a decisão de id 96029202 seja reformada pelo indeferimento da tutela provisória de urgência, sob argumento de que não estavam presentes todas as condições para o fornecimento da bomba de insulina e seus insumos [id 118922861].

Decisão determinou o cumprimento da decisão de indeferimento da tutela de urgência [id 130126479].

Em réplica o autor impugnou as alegações defensivas e ratificou os termos da inicial [id 131951775].

Decisão saneadora fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova [id 193214013].

Em provas, manifestaram-se as partes em conformidade com a certidão dos autos [id 205225812].

É o breve relatório. Fundamento e DECIDO.

II. FUNDAMENTOS:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por **LEONARDO MICHALICK THOMASI** em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.**

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a matéria é eminentemente de direito. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, motivo pelo qual é desnecessária a dilação probatória. O juiz é o destinatário das provas (art. 370 do CPC), sendo seu dever e não faculdade anunciar o julgamento antecipado quando presentes os requisitos legais, em virtude do princípio da razoável duração do processo, adotado de forma expressa como norteador da atividade jurisdicional (art. 4º, CPC).

Presentes as condições para o regular exercício do direito de ação, bem como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, passo ao exame do mérito.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a ela se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré é fornecedora, enquadrando-se nas disposições do artigo 3º e seus parágrafos, e a parte autora é consumidora, nos termos do artigo 2º, *caput*. Além disso, presente também o requisito objetivo para a configuração da citada relação, qual seja, o fornecimento de serviços pela parte ré, mediante pagamento, conforme o §2 º do artigo 3º, também do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608-STJ).

Cinge a controvérsia da demanda em aferir a obrigatoriedade de custeio, por parte da operadora de saúde, do tratamento indicado com bomba de infusão de insulina e seus insumos, bem como os danos morais decorrentes deste fato.

Assiste razão a parte autora.

Inicialmente, destaque-se que saúde é direito social, fundamental de segunda dimensão, previsto no art. 6º da CRFB, diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nos contratos de plano privado de assistência à saúde, a regra é a cobertura contratual, devendo as exceções, que importam restrição à cobertura contratada, estar expressamente previstas, por cláusula clara e que não coloque o consumidor em excessiva desvantagem, sob pena de violação à boa-fé que deve pautar as relações negociais, mormente quando existente entre as partes relação de consumo.

O autor, beneficiário de plano de saúde, é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID - E10) de difícil controle. Em razão dessas condições, conforme atestado por médico [id 94070982], o autor necessita de tratamento com Bomba Infusora de Insulina com sensor e sistema Minimed 780G.

Analisando os autos, observa-se que a ré negou a autorização da cobertura do tratamento, sob o fundamento de que não estariam previstos no Anexo I do Rol de Procedimentos da ANS, conforme a RN nº 465. Todavia, a **jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP**, reconhece que o rol da ANS possui caráter taxativo, mas admite exceções, desde que observadas determinadas circunstâncias, especialmente quando evidenciada a necessidade do tratamento por indicação médica.

O médico especialista prescreveu o uso de uma bomba de infusão contínua de insulina, modalidade de tratamento indicada para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 que não conseguem manter o controle glicêmico adequado com outros métodos, como aplicações de insulina.

A princípio as operadoras de plano de saúde não têm obrigação de fornecer ou custear medicamentos prescritos pelo médico assistente para uso fora do ambiente hospitalar. No entanto, o sistema de infusão contínua de insulina (SICI), ou bomba de insulina, não se classifica como medicamento, mas sim como um dispositivo médico. Portanto, ele não se enquadra no art. 10, VI, da Lei nº 9.956/1998 e, por esse motivo, não pode ser excluído do rol de cobertura das operadoras de planos de saúde.

No caso concreto, a **prescrição médica constante no laudo médico** [id 94070982] **não diverge do entendimento firmado pelo STJ,** o qual decidiu que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. Portanto, a cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não

estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei nº 14.454/2022.**Vejamos "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.11.2024.**

(REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/1/2025.)

Ressalte-se, ainda, que, apesar do tratamento não estar listado no rol da ANS, sua cobertura é permitida devido às inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, que adicionou o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998:

> Art. 10 (...)
>
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
>
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
>
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Neste ponto, importante ressaltar que a eficácia da bomba de insulina é reconhecida em pareceres do NATJUS, tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, contando inclusive com a Nota Técnica nº 242/2022. Vejamos:

> "Há evidência científica de boa qualidade que demonstra que o uso de bomba de insulina (ou sistema de infusão contínua de insulina, SICI) ao invés de múltiplas doses de insulina (MDI) como tratamento para DM1, tem um pequeno impacto no controle glicêmico e impacto incerto sobre a ocorrência de hipoglicemias graves.
>
> Cabe ainda ressaltar que a tecnologia pleiteada apresenta alto custo de manutenção. Ressaltamos a imprescindibilidade da consideração deste aspecto, não só na definição de política de saúde pública mas também em decisões individuais, sob risco de inadvertidamente prover atendimento privilegiado, com recursos públicos extraídos da coletividade - recursos públicos que, mesmo em países ricos, são finitos e possuem destinações orçamentárias específicas com pouca margem de realocação, e cuja destinação inadequada pode acarretar prejuízos à toda população assistida pelo SUS.
>
> Porém, **a decisão favorável para o caso em tela se justifica pelos bons resultados de controle glicêmico com o uso da bomba de insulina, incluindo a redução de hipoglicemias graves e minimização de agravos decorrentes do diabetes** que a parte autora já apresenta. Desta forma, entendemos que (apesar da evidência científica de benefício limitada) o pleito para tratamento com bomba de insulina é adequado, em caráter excepcional, em função das características apresentadas pela paciente."

A controvérsia do caso constitui objeto do **Tema Repetitivo 1316,** que trata da " PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. LEI N° 9.656/1998. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. 1. Delimitação da controvérsia: "definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle

contínuo de glicose pelos portadores de diabetes". 2. Recurso especial afetado ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do CPC. **(ProAfR no REsp n. 2.168.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)**

Negar cobertura ao tratamento prescrito, quando ele se mostra necessário para garantir a saúde do beneficiário, compromete a boa-fé contratual e vulnera a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é assegurar o acesso a cuidados médicos adequados.

Assim, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, **merece acolhida o pedido para que a ré custeie o tratamento de diabetes do autor, consistente na Bomba de Infusão de Insulina, insulinas, além dos insumos e materiais que sejam necessários ao sucesso do tratamento, de forma mensal e até ulterior decisão médica, limitado ao período de vigência do contrato**.

Também **merece acolhida o pedido de indenização por danos morais**, diante da falha na prestação do serviço do réu, restando caracterizado o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, nos termos do **verbete sumular Nº. 339 do TJRJ** "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral."

Tendo em vista a extensão do dano (CC, art. 944), o poder socioeconômico das partes, a função pedagógica do dano moral, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo a indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

III – DISPOSITIVOS:

1) Isto posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** contido na petição inicial para:

A) CONDENAR ar ré na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em **custear integralmente o tratamento do autor com a Bomba de Infusão de Insulina, insulinas, além dos insumos e materiais que sejam necessários ao sucesso do tratamento, de forma mensal e enquanto perdurar a necessidade médica, observado o limite temporal da vigência do contrato.**

B) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de **juros de mora** de acordo com a **Taxa Selic deduzido o IPCA** (art. 406, §1º, CC), **a contar da citação até a data desta sentença**, momento a partir do qual incidirá apenas a **Taxa Selic de forma integral**, a qual engloba os juros de mora e a correção monetária devida a contar do arbitramento **(súmula 339 do STJ**).

D) CONDENAR a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, "caput" e §2º, incisos I a V, do CPC.

Sentença sujeita ao art. 523, § 1º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e inerte a parte interessada, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Núcleo de Arquivamento para a certificação das custas finais e o arquivamento definitivo dos autos, na forma do artigo 229-A da CNCGJ.

Antes da remessa dos autos ao Núcleo de Arquivamento, deve o Cartório cumprir o determinado no §1º do artigo 229-A da CNCGJ. P.I.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SÃO JOÃO DE MERITI, 7 de agosto de 2025.

AKIRA SASAKI
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: AKIRA SASAKI
08/08/2025 12:37:08
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25080812370790100000204629083

IMPRIMIR GERAR PDF